

Ви лікар-педіатр-неонатолог акушерського стаціонару.

Ви у пологовій залі надаєте допомогу новонародженому, який народився від I вагітності, строк гестації 37 тижнів, перебіг вагітності неускладнений, пологи фізіологічні. Вага при народженні 2950 г.

Відмічалось двократне обвиття пуповиною навколо шиї.

Ви констатуєте, що дитина неактивна, послаблене дихання, шкірний покрив ціанотичний, слизові оболонки рожеві, зниження м'язового тону, смоктальний рефлекс відсутній. Аускультативно у легенях дихання послаблено у базальних відділах. ЧД 67/хв. Сатурація 93%. Тони серця приглушені, брадикардія, ЧСС 84 уд/хв. За шкалою Апгар 5-6 балів.

Біохімічний аналіз крові

Кислотно-лужний стан (пуповинна кров):

pH - 7,15 (7,25-7,35)

дефіцит основаній (BE) -13 ммоль/л (до

6,0) Глюкоза крові: 2,9 ммоль/л (2,6-5,0)

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановити контакт з колегами та жінкою, яка щойно народила (привітатись, представитися, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт	Доброго дня. Я лікар педіатр-неонатолог.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	У дитини важкий стан, я маю надати невідкладну допомогу.
2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги (зі слів колег)	Дитина активна? Очікувана відповідь: дитина неактивна
2.2	Акушерський анамнез	«Який термін гестації та перебіг вагітності?» Очікувана відповідь: «від I вагітності, строк гестації 37 тижнів, перебіг вагітності неускладнений»
2.3	Перебіг пологів	Які особливості перебігу пологів? Очікувана відповідь: пологи фізіологічні. Вага при народженні 2950 г. Відмічалось двократне обвиття

		пуповиною навколо ший.
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички, обробити оліву та мембрани фонендоскопу серветкою з антисептиком, оцінити загальний стан.	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки та фонендоскоп оброблені Сказати:дитина неактивна, послаблене дихання, шкірний покрив ціанотичний, слизові оболонки рожеві, зниження м'язового тону, смоктальний рефлекс відсутній. За шкалою Апгар 5-6 балів.
3.2	Обстеження дихальної системи	Сказати:Аускультативно у легенях дихання послаблено у базальних відділах. ЧД 67/хв. Сатурація 93%.
3.3	Обстеження серцево-судинної системи	Сказати:Тони серця приглушені, брадикардія, ЧСС 84 уд/хв.
4.Діагностика		
4.1	Визначити результат кислотно-лужний стан крові	Респіраторний ацидоз
4.2	Оцінити рівень глікемії	нормоглікемія
4.3	Визначити провідний синдром	дихальної недостатності
4.4	Встановити клінічний діагноз	Асфіксія новонародженого, середнього ступеня тяжкості.
5.Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	(Перенести дитину на реанімаційний стіл, під джерело тепла, санація слизу, тактильна стимуляція, 100% O2 через маску.) Переводимо дитину у відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати:здоровий спосіб життя жінки, грудне вигодовування, загартовування
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування батьків/опікунів про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати:Ви повинні знати про можливі ускладнення асфіксії